Station 1

Linus, 5 år kommer tillsammans med sin pappa till dig på barnmottagningen på remiss från hälsocentralen. Linus har senaste halvåret sökt tre gånger på primarvårdsjouren för andningsbesvär i samband med förkylning. Du läser i remissen att han haft väsande andning och expiratoriska rhonki vid undersökning.

Du ska:

- **Komplettera anamnesen**
- **Förklara sannolik diagnos för medföljande pappan**
- **Informera kort om vidare handläggning**

Barnet är en docka, i rummet finns en pappa som du får prata med.

Station 1 Pediatrik - litet barn med astma **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Gör adekvat bedömning av symtom	1	0.5	0
Ställer diagnosen astma	1	- NA -	0
Beta-2-stimulerare: Förklarar effekten adekvat	1	0.5	0
Beta-2-stimulerare: Ordination vid behov	0.5	- NA -	0
Inhalationssteroid: Förklarar effekten adekvat	1	0.5	0
Inhalationssteroid: Regelbunden användning 1-2 gånger dagligen	0.5	- NA -	0
Informerar på föräldern fråga ”om kortison är farligt” att barn kan få hämmad längdtillväxt och att längden ska följas regelbundet	1	0.5	0
Informerar på föräldern fråga ”om kortison är farligt att barn kan få svampinfektion i munhåla och vikten av att skölja/borsta tänderna efter inhalationen	1	0.5	0
Informerar och förklarar för föräldern på ett begripligt sätt om inhalator/spacer	2	1	0
Förmåga att utöva ett patientcentrerat förhållningssätt (2-0p) • Tillfredsställande: Mycket god individcentrering: Visar tydligt att hen utgår från patientens person i den sammanvägda bedömningen och för samtalet om planerade åtgärder i samråd med patienten på ett tydligt sätt (2p) • Delvis tillfredsställande: Uppvisar basala krav på individcentrering: Tar hänsyn till patientens signaler och frågar aktivt efter patientens uppfattning (1p) • Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra uppgiften med lyhördhet för patientens uppfattning (0p)	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 3

Frida 34 år kommer till dig på vårdcentralen då hon av och till de senaste månaderna upplevt en molande smärta i höger fossa. Idag är hon helt smärtfri. Hon menstruerar regelbundet i 4-5 dagar var 26-28:e dag, I-para med partus normalis för 2 år sedan, tidigare gyn-frisk.

Du ska:

- **Genomföra en korrekt gynekologisk undersökning och beskriva dina undersökningsfynd avseende utseendet av vulva, vagina och portio/cervix**

- **Göra en storleksbedömning av livmodern**

- **Sammanfatta patientfallet enligt SBAR**

Station 3 Ob/Gyn - Undersökning **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten ställer in ljuskällan och höjd på gyn-stol korrekt	1	0.5	0
Studenten för in undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt	2	1	0
Studenten rapporterar normala fynd i vulva, vagina och portio/cervix	1	0.5	0
Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar att uterus är normalstor	1	- NA -	0
Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik	3	1.5	0
Studenten sammanfattar patientfallet för bedömaren enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 4

Din nästa patient på vårdcentralen är en kvinna som är orolig för en knöl i höger bröst.

Du ska:

- **Genomföra en bröstundersökning.** Undersökningen görs på en docka som hanteras av en figurant.
- **Kommunicera med figuranten under undersökningen som om det vore en patient**
- **Informera patienten om dina fynd och föreslå vidare handläggning**

Station 4 Onkologi - Knöl i bröstet **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kommunicerar på ett adekvat sätt med pat under us	1	0.5	0
Inleder med att inspektera brösten	1	- NA -	0
Använder bimanuell palpationsteknik	1	- NA -	0
Palperar även i liggande	1	- NA -	0
Undersöker mamillerna	1	- NA -	0
Strukturerad och metodisk undersökningsteknik	1	0.5	0
Hittar resistensen i höger bröst	1	- NA -	0
Hittar resistensen i vänster bröst	1	- NA -	0
Sammanfattar undersökningsfyndet och beskriver fortsatt utredning	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 5

Din nästa patient på hälsocentralen är en 72-årig man som söker på grund av obehag och smärta i höger underben och fot vid promenader sedan ett par månader tillbaka. Han är tidigare storrökare, men är rökfri senaste året. Medicinerar med amlodipin, candesartan och senaste året även med metformin.

Initial misstanke om djup ventrombos respektive kompartmentsyndrom har avskrivits.

Du ska:

- **Komplettera anamnesen**
- **Genomföra ett diabetesfotstatus**
- **Informera patienten om din bedömning och eventuell fortsatt utredning**

Övrig klinisk undersökning/status och behandlingsförslag ingår INTE i uppgiften.

Station 5 Internmed - Perifer cirkulation **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej Tillfredsställande
Frågar om: Smärtans/obehagets lokalisation och karaktär. Gångsträcka, bättre vila? Bedömning: 1p för fråga om gångsträcka 1p för fråga om förbättring av smärta/obehag i vila.	2	1	0
Inspekterar båda benen och fötternas ovansidor, fotsulor och mellan tårna Bedömning: 1p för inspektion av fötternas ovan och undersidor. 0,5p inspekterar bara symtomatisk sida	1	0.5	0
Palperar a dorsalis pedis bilateralt Bedömning: 1p vid tillfredsställande teknik båda sidor(palperar med två fingrar på rätt ställe). 0,5p palperar bara symtomatisk sida	1	0.5	0
Palperar a tibialis posterior bilateralt Bedömning: 1p vid tillfredsställande teknik (palperar med två fingrar på rätt ställe). 0,5p undersöker bara symtomatisk sida	1	0.5	0
För palpation av fotpulsar: **Bedömer** ev. skillnad mellan höger och vänster sida Bedömning: 1p vid samtidigt bilat palpation eller uttalar bedömning av sidoskillnad.	1	- NA -	0
Vibrationssinne med stämgaffel: Kontrollerar först att patienten förstår. Testar båda fötterna adekvat vid stortåbasen och mediala malleolen. Bedömning: 1p om testat vibration på 2 positioner på båda fötter enligt ovan. 0,5p undersöker bara symtomatisk sida	1	0.5	0
Känsel med monofilament: Kontrollerar först att patienten förstår. Testar båda fötterna adekvat på minst 3 punkter (under stortå + 2 punkter under framfot) Bedömning: 1p om testat känsel på 3 positioner på båda fötter enligt ovan. 0,5p undersöker bara symtomatisk sida	1	0.5	0
Professionalitet: Övergripande bedömning av patientbemötande (hälsar artigt), kommunikations-förmåga och patientinformation. Använder ”lekmannasvenska”, dvs förståeligt språk för ej medicinskt insatt. Bedömning: 1p om professionellt patientbemötande Informerar patienten om att undersökningen visar att cirkulationen och känseln är sidlika MEN att en komplettering med ABI behöver göras för att utesluta fönstertittarsjuka. Bedömning: 1p om rekommenderar fortsatt utredning avseende kronisk perifer artärsjukdom/insufficiens ex. AB-index eller ultraljud.	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 6

En 20-årig kvinna kommer till akutmottagningen på grund av tilltagande svaghet i armar och ben sedan en vecka, även domning i fötterna. Hon har inte slagit sig, är helt vaken och är uppegående med vissa svårigheter. Inga andningsbesvär.
Från triagen får du veta att hon har bra blodtryck och puls samt är afebril.

Du ska:

- **Utföra relevanta delar av rutinnervsstatus**
- **Informera patienten om var skadan troligen sitter, samt vidare utredning**

Du ska INTE ta anamnes eller undersöka grad av pareser

Nervstatus	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Undersöker något av ansiktsmotorik eller ögonmotilitet (1 poäng)	1	- NA -	0
Undersöker reflexer alla fyra extremiteter (1 reflex per extremitet räcker) (2 poäng)	2	- NA -	0
Undersöker känsel för stick och vibrationssinne enligt rutinnervstatus (1 poäng) (0,5 poäng vid ofullständig men informativ känselundersökning)	1	0.5	0
Undersöker om nivå för känsel finns på bålen (1 poäng)	1	- NA -	0
Kontrollerar Babinskis tecken (tops/tandpetare krävs för poäng) (1 poäng)	1	- NA -	0
Bedömning	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Informerar patienten om att skadan sitter i perifera nervsystemet/Guillain Barre) (1poäng)	1	- NA -	0
Fortsatt utredning inneliggande på sjukhus (1 poäng)	1	- NA -	0
Lumbalpunktion (0,5 poäng)	0.5	- NA -	0
EMG/neurografi (0,5 poäng)	0.5	- NA -	0
Bra bemötande, personcentrerat, god kommunikation (1 – 0,5-0 poäng)	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 7

Du vikarierar som underläkare på en röntgenavdelning. En läkarstudent på termin 8 följer med dig. Du har fått tre patienters undersökningar att granska.

Du ska:

- **Tolka bilderna och välja diagnos från angivna diagnosalternativ**
- **Tala om för studenten vilken diagnos du valt**
- **Visa, förklara och motivera vad du har hittat**

Station 7 Bild- och funktionsmedicin, 15/11/2023 SKARP 6 min Candidate:

Fall 1 Levermetastas	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Valt diagnosalternativ: Korrekt diagnos, Levermetastas =1p. Övriga alternativ=0p.	1	- NA -	0
Demonstration: **Peka ut fynd/fynden + ange korrekt lokalisation** Höger leverlob (lokalisation) = 0,5p. Förklarar egenskaper: högmetabol på PET, intermediär/låg signal på MR, ses ej på CT. Anger minst 2 av ovanstående: 0,5p. Anger färre än 2 av ovanstående =0p.	1	0.5	0
Demonstration **Förklara/motivera diagnosen** Anger att metabolism + MR + anamnes talar för metastas =1p. Anger minst 2 av ovanstående= 0,5p. Övriga alternativ=0p.	1	0.5	0
Fall 2 Övertryckspneumothorax	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Valt diagnosalternativ: Korrekt diagnos Övertryckspneumothorax =1p. Pneumothorax = 0,5p. Övriga alternativ =0p.	1	0.5	0
Demonstration: **Peka ut fynd/fynden + ange korrekt lokalisation.** Peka ut: vänster hemithorax är i det närmaste helt luftfylld =0.5p Medellinjesstrukturer överskjutna åt höger = 0,5p	1	0.5	0
Förklara/motivera diagnosen Skillnad mellan ventil/icke ventil. Övertryck har överskjutning av medellinjesstrukturer =0.5p Förklara att detta kan orsaka cirkulationskollaps =0.5p	1	0.5	0
Fall 3 DT hjärna ICH	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Valt diagnosalternativ: Intracerebralt hematom = 1p Övriga alternativ =0p.	1	- NA -	0
Demonstration: **Peka ut fynd/fynden och motiverar diagnos:** Visar, pekar på blödningen (ICH) = 0,5p. Anger att färsk blödning är högattenuerande/vitt = 0,5p.	1	0.5	0
Demonstration: **Visar fynden, korrekt lokalisation:** Anger rätt sida (ICH), höger = 0,5p. Anger blod i ventriklarna = 0,5p.	1	0.5	0
Demonstration: **Visar fynd 2 och motiverar tecken på expansiv effekt:** Visar överskjutning av medellinjen, kompression av sidoventriklar, utslätade fåror. Anger minst 2 av ovanstående= 1p. Anger 1 av ovanstående = 0,5p.	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 9

Din nästa patient på akutmottagningen är en 69-årig man som sedan 2 veckor haft svårt att tömma urinblåsan. För 2 dagar sedan tillkomst av hög feber, frossbrytningar och illaluktande urin. Anhöriga har berättat för sjuksköterskan att patienten var knappt kontaktbar så de ringde ambulans. Sköterskan är kvar på rummet och har tagit vitalparametrar.

Du ska:

- **Bedöma patienten**
- **Informera patienten om trolig diagnos och åtgärd**
- **Förklara för sköterskan din bedömning om diagnos och svårighetsgrad samt ordinera**
    - **Provtagning och initial behandling**
    - **Lämpliga kontroller och vårdnivå**

Du ska INTE göra kroppsundersökning med status

Station 9 Infektion - Handläggning sepsis, 15/11/2023 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar upp en strukturerad anamnes	1	0.5	0
Bedöma svårighetsgraden utifrån Sepsis3/SOFA-kriterierna eller andra scoringsystem. Bedömer om patienten har konfusion.	1	0.5	0
Informerar patienten att den primära misstanken är urosepsis med septisk chock	1	- NA -	0
Efterfrågar information om eventuell allergi mot antibiotika	1	- NA -	0
Ordinerar: Elstatus inkl kreatinin, blodst; laktat, APTT, PK, blodsocker; (0,5p var) urinodling, blododling x 2 (0,5p var)	2	1	0
Ordinerar antibiotika enl STRAMA vid urosepsis med septisk chock: piperacillin-tazobactam 4gx4 eller cefotaxim 2gx3 + aminoglykosid 5-7mg/kg alternativt singelbeh med imipenem/meropenem 1gx3	2	1	0
Ordinerar iv Ringer-acetat - Ett riktvärde på 30 ml/kg under de 3 första timmarna (0,5p)+ KAD (0,5p) ordinerar syrgas näskateter (2-3 l) Målsaturation 92–95%	1	0.5	0
Ordinerar inneliggande vård med kontroll av vitalparametrar x48, samt mätning av urinproduktion (0,5p var)	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 10

Din nästa patient på vårdcentralen är 67 år och tidigare frisk. Kommer nu för att synen långsamt försämrats på ena ögat. Synskärpa hos optiker: höger öga 1,0 vänster 0,5.

Du ska:

- **Välja sort och applicera en ögondroppe på korrekt sätt i ett av patientens ögon inför undersökning**
- **Undersöka patienten med så kallat genomfallande ljus.** Du får en bild på vad du ser efter genomförd undersökning.
- **Informera patienten om undersökningens resultat och vidare handläggning**

Station 10 Ögon - Droppteknik samt undersökning i genomfallande ljus, 15/11/2023 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Välja rätt substans och kontrollera att det är korrekt – 1-0,5-0p	1	0.5	0
God droppteknik – 1-0,5-0p	1	0.5	0
Ställa in rätt ljus i oftalmoskopet – 1p ... och ok dioptrital – 1p.	2	1	0
Hålla oftalmoskopet korrekt – 1p ...samt på rätt avstånd från patienten – 1p.	2	1	0
informera patienten med rätt diagnos 1p	1	- NA -	0
patientcentrerat och så patienten förstår 1-0,5-0p	1	0.5	0
informerar om korrekt fortsatt handläggning 2-1-0p	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 11

Stina, 78 år kommer till dig på vårdcentralen på grund av nedsatt hörsel. Hon har gjort en hörselmätning.

Du ska:

- **Ta en kort men adekvat anamnes**
- **Undersöka patienten.** Berätta högt vad du gör och hur du tolkar resultat på undersökningar.
- **Tolka audiogrammet och förklara för patienten**
- **Informera patienten om mest trolig diagnos och vidare handläggning**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Om studenten tar en kort riktad anamnes, Yrsel?, Tinnitus?, Sidoskillnad? (1p). (0, 0,5, 1p)	1	0.5	0
Om studenten säger att hen undersöker: 2p (otoscopi eller öronmicroskopi-1p, weber-1p). (0,1,2p)	2	1	0
Om studenten säger att hen tittar i öronen så visar bedömaren bilder av höger och vänster trumhinna. (normal trumhinna bilateralt 1p).(0,1p)	1	- NA -	0
Om studenten säger att hen utför weber och visar hur hen gör detta, säger figuranten att hon hör tonen mitt i huvudet. (korrekt beskrivning-1p)(0,1p)	1	- NA -	0
Om studenten tolkar audiogrammet (korrekt tolkning dvs. liksidig nedsättning i diskanten av både luft och benledning= sensorineural hörselnedsättning ger 2p) (0,1,2p).	2	1	0
Om studenten anger diagnos:.(presbyacusi-1p)	1	- NA -	0
Om studenten anger: (erbjuda hörhjälpmedel-1p).	1	- NA -	0
Om studenten bemöter patienten på ett adekvat sätt (1p) (0, 0,5, 1p)	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 12

En 65-årig före detta rökare har hostat blod vid upprepade tillfällen senaste månaden och har därför fått göra en lungröntgen. Varken kliniskt eller lab-mässigt finns det några misstankar om pågående infektion.

Röntgensvar:

Centralt i höger ovanlob finns ett 4 cm stort rundat infiltrat. Prominent höger lunghilus. Ingen pleuravätska.

Patienten är nu hos dig på Hälsocentralen för besked om röntgenssvar och ställningstagande till vidare utredning.

Du ska:

- **Informera om röntgenfyndet, vad det föranleder och varför**
- **Berätta kortfattat för patienten om fortsatt utredning; undersökningar som ingår och vem som håller i utredningen**

Du ska INTE komplettera anamnes med avseende på symtombild och rökvanor!

Station 12 Lungmedicin - Misstänkt lungcancer, 15/11/2023 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Information angående röntgenfynd	1	0.5	0
Initial åtgärd	2	1	0
Inledande utredning och motivation	2	1	0
Fortsatt utredning	2	1	0

	3 poäng	2 poäng	1 poäng	0 poäng
Professionalitet	3	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 14

Du är underläkare på en reumatologklinik. Du träffar en 35-årig patient med nydiagnostiserad reumatoid artrit (RA) där en bedömning gjorts att det finns indikation för insättning av metotrexat. Inga kontraindikationer för metotrexat har identifierats vid provtagning eller anamnes.

Du ska:

- **Utföra ett ledstatus av handled och av mcp- och pip-leder i syfte att identifiera artriter**
- **Ge patienten adekvat information inför insättning av metotrexat**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Professionellt och empatiskt **förhållningssätt** i konsultationen	2	1	0
Handled: **Synovit:** identifiera ledspringan på dorsalsidan	1	0.5	0
Rörelseförmågan: ”Lucia” och omvänd ”Lucia” eller motsvarande för att bedöma flektion och extension i handled. Passiv palmar- och dorsalflexion går också bra	1	0.5	0
Mcp-leder: **Synovit:** Omväxlande tryck tumme/pekfinger och stöd med övriga fingrar palmart eller likande variant såsom tryck med tummar på vardera sidan om mcp-leden och stöd med pekfingrar och övriga fingrar palmart	1	0.5	0
Pip-leder: **Synovit:** Fyrfingergrepp, tumme och pekfinger från vardera handen och tryck omväxlande från lateral/medialsidan respektive dorsal och volarsidan. Liknade varianter med syfte att ”stänga in” synoviten kan också godkännas	1	0.5	0
Rörelseförmågan i fingrarna: Knyt fingrarna, finns knydiastas? Extendera fingrarna maximalt, finns extensionsdefekter?	1	0.5	0
Förklarar att behandlingen minskar inflammation alt att utebliven behandling medför risk för ledskador	1	0.5	0
Förklarar på ett adekvat sätt vad behandling med metotrexat innebär (kontrollprover, dosering en gång per vecka, behov av antikonception, 2-3-månader till behandlingssvar, vanliga biverkningar, allvarliga biverkning)	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 15

Din nästa patient på akutmottagningen har skurit sig i handen på en glasruta.

Du ska:

- **Utföra ett för skadans lokalisation relevant och utförligt handstatus.** Berätta högt vad du gör så att patienten förstår.
- **Informera patienten om vilka strukturer som är skadade, samt fortsatt handläggning**

Det du ser eller hittar i handstatus är vad du ska kunna se.

Station 15 Handkirurgi - Handstatus vid sårskador på handryggen, 15/11/2023 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Inspektera sår	0.5	- NA -	0
Test av kapillär återfyllnad: trycker på fingerblomma eller nagel, bedömer återflödet normalt, som väntat	0.5	- NA -	0
Test av sensorik: beröringskänsel på handryggen, radialt och ulnart	1	0.5	0
Test av EPL: sträcka IP och lyfta tummen från bordet med handflatan mot detta.	1	0.5	0
Test av EDC: Sträcka alla fingrar i MCP, även enskilt med övriga mot underlaget.	1	0.5	0
ECRL/ERCB: extendera/radialdeviera i handleden	1	0.5	0
Rätt slutsats nerv bortfallen känsel n radialis dorsalisgrenen.	1	0.5	0
Rätt slutsats senor dig 1 konstatera bortfall i extension IP 1 och av lyftförmåga av tumme från bord	1	0.5	0
Rätt slutsats senor fingrar konstatera bortfall EIP och EDC 2, övriga intakta.	1	0.5	0
Rätt slutsats senor Konstatera att ECRL och ECRB är intakta	0.5	- NA -	0
Rätt handläggning sårtvätt, sutur och remiss för operation	1.5	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 16

Din nästa patient på hälsocentralen är Miki 67 år, som nyligen tagit en 4 mm stansbiopsi i en 10 mm rodnad förändring på ryggen. Du har precis fått svar att det rör sig om en basalcellscancer typ 1B.

Du ska:

- **Informera patienten om diagnosen**
- **Ta en riktad anamnes**
- **Ge förslag på fortsatt handläggning**
- **Ge patienten lämpliga råd**

Du ska INTE undersöka patienten!

Station 16 Hud - Hudförändring, 15/11/2023 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes	2	1	0
Prevention	2	1	0
Behandling	2	1	0
Patientens frågor och farhågor	2	1	0
Kommunikation	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 18

Astrid, 63 år kommer till dig på kirurgmottagning då hon noterat att det har kommit rött blod med avföringen.

Hon bor i villa med make, har arbetat i en affär och har två vuxna barn. Hon är tidigare frisk, är inte opererad och äter inga mediciner. Hon har inga allergier och brukar inte tobak eller alkohol.

Du ska:

- **Komplettera en riktad anamnes**
- **Genomföra bukstatus på docka.** Berätta högt vad du gör.
- **Informera patienten om eventuella undersökningsfynd och föreslå vidare handläggning**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Frågar om symptom från buken (buksmärta, förändrade avföringsvanor o.s.v.)	1	0.5	0
Frågar om symptom och riskfaktorer för cancer (hereditet, viktnedgång o.s.v.)	1	0.5	0
Systematisk och professionell palpation av hela buken	1	0.5	0
Bedöming av muskeltonus och ömhet	1	0.5	0
Identifikation av buktumör	2	1	0
Föreslå undersökning per rectum (eller PR/rektoskopi)	1	0.5	0
Föreslå coloskopi (eller CT colon, 1p)	2	1	0
Förklara vad en coloskopi eller CT colon är	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10